随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.特点

主要效应是调节呼吸	通过呼吸运动改变影响心血管活动
平时对血压不起调节作用 只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节 大失血	对比窦弓反射： ①随时随地都在起作用 ②又称为降压反射
又称为升压反射，进行单向调节	③进行双向调节
维持内环境的相对稳定 **危急情况** **维持心、脑重要器官的血供**	大失血时交感神经兴奋可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张（**血量重新分配**）

（三）心肺感受性反射

1.心肺容量感受性反射

（1）感受器

①位于**心房、心室、肺循环大血管**，称为：

容量感受器	血容量增多后刺激感受器
牵张感受器	血容量增多后使感受器扩张
低压力感受器	感受器位于循环系统压力较低部分

容量变化

②主要感受心血管牵张的机械刺激（如回心血量增多刺激感受器），也感受某些化学物质的刺激（如腺苷、前列腺素、缓激肽）

平均充盈压↑→搏出量↑→收缩压↑↑、舒张压↑、平均动脉压↑

（2）**效应：**血容量↑→血压↑→交感神经↓、迷走神经↑

↓　　→ 血压↓

钠尿肽↑→ADH↓、醛固酮↓→血容量↓

乌苷酸环化酶受体通路：拮抗RAAS

一尿GC

2.心交感传入反射 十版新增

心衰　　心肌缺血

①感受心室扩张的机械刺激和腺苷↑等化学刺激，在心肌缺血时致交感神经兴奋以维持血压

②交感神经兴奋增加心肌耗氧，参与心衰、高血压交感神经的过度激活（**疾病恶性循环的正反馈**）

β-R拮抗剂：解决交感N过度激活问题，对心衰、高血压友好（抗重构）